

Lactrodectus: viuda negra

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Neurotoxina: acción estimulante del simpático y aumenta la concentración de Ca intracelular en las neuronas estimulando la exocitosis de los neurotransmisores.

Clínica

Local

- De 15-60min de producida la picadura
- Eritema
- Dolor local punzante, q puede irradiarse
- Pilo erección y contracturas musculares en el área de la picadura
- No hay necrosis tisular.

Generales

- Edema bipalpebral, con hiperemia de cara y cuello
- Dolores musculares e hiperestesia cutánea muy intensos
- Sensación de muerte inminente, taquicardia o bradicardia con aumento de la TA
- Nauseas, vómitos, constipación, hepatomegalia
- Priapismo, enuresis oliguria por paresia vesical
- Sialorrea, midriasis, excitación, ansiedad pseudo psicosis

Laboratorio:

Hemograma: Leucocitosis, Linfopenia, Eosinopenia

Glucemia: Hiperglucemia

Fósforo: Hiperfosfatemia

EA/B

CPK

Amilasemia

Sedimento urinario: Albuminuria, Hematuria, Leucocituria, Cilindruria

E.C.G.: se pueden observar arritmias cardíacas como fibrilación auricular y bloqueos, disminución del amplitud del QRS y de la onda T, inversión de la onda T, alteración del segmento ST y prolongación del intervalo QT.

Tratamiento

Leve Dolor local Edema local discreto Sudoración local Dolor en miembros inferiores Parestesias en miembros	Sintomático. Analgésicos. Gluconato de calcio 10%, E.V. Observación.
Moderado: <i>además de los referidos.</i> Ansiedad / agitación Temblores y contracturas Dolor abdominal Sudoración generalizada Mialgias Dificultad para caminar Cefalea	Sintomático. Analgésicos. Gluconato de calcio 10%, E.V. Específico. Administración E.V. de antiveneno latrodectus 1 ampolla – “Inst. Malbrán”
Grave: <i>además de los referidos.</i> Taqui / bradicardia Hipertensión arterial Taquipnea / disnea Nauseas y vómitos Retención urinaria	Sintomático. Analgésicos. Gluconato de calcio 10%, E.V. Específico. Administración E.V. de antiveneno latrodectus 1 amp, repetir en una hora, ante la no mejoría

Loxocela: cajonera o rinconera

- De color gris, marrón o negrozco
- La tela es adherente y pegajosa blanca, algodonosa e irregular
- Se encuentra en lugares secos y oscuros
- Veneno: dermonecrótico y hemolítico

Cuadro cutáneo

- Dolor punzante, urente o puede ser indolora
- Eritema y edema en la zona de la picadura, no deja godet
- Progresa a áreas equimóticas q dan a la piel un color rojo violáceo.
- A las 48 hrs se forman vesículas o ampollas serosanguinolentas
- Al 5-7 día se forma una escara q se desprende a la segunda semana quedando una ulcera necrótica superficial negra
- Entre 4-7 semana se produce la cicatrización

Cutáneo visceral

- Cuadro sistémico que se asocia a muerte por CID, hemólisis e insuficiencia renal aguda
- En el curso de las 12 hrs: fiebre, malestar general vértigo náuseas, vómitos diarrea, cefalea, erupción generalizada, picazón, hipotensión, artralgia, dolores musculares, visión borrosa, somnolencia, ictericia, anemia, hemólisis

Laboratorio

- Hemograma: leucocitosis con neutrofilia, anemia hemolítica, plaquetopenia
- VSG: aumentada
- Hepatograma: hiperbilirrubinemia a predominio indirecta, alteración enzimática
- TP, TTPK: alteradas
- Función renal
- Orina: hematuria, hemoglobinuria

Tratamiento

Leve Síndrome local de poco relieve, donde la necrosis, de presentarse, es pequeña y superficial. El dolor y el edema son poco manifiestos. Evoluciona hacia la curación.	Observación durante 12 hs. Hielo local, elevar el miembro afectado, vacuna antitetánica Calmar el dolor, no usar salicilatos Calmar el prurito con Difenhidramina. Laboratorio a las 6 hs.
Moderado La necrosis es constante, precedida o no por la clásica placa livoide. El dolor es constante, urente y de mediana intensidad. Edema manifiesto y doloroso a la presión. Pueden aparecer vesículas. El compromiso sistémico es inconstante y limitado a escalofríos, astenia, hiporexia, que desaparecen al cabo de pocas horas.	Observación durante 24 hs. Sintomático Antiveneno loxosceles Cuando el dolor es urente y la presencia de la pápula o placa persiste más allá de las 6 a 12 hs de producida la picadura. Laboratorio a las 6 y 24 hs.
Grave Lesión cutánea tiende a extenderse a zonas vecinas. Signos locales de tipo discrálicos. El compromiso general es constante, siendo el aparato circulatorio y renal los más afectados. La tendencia al CID y a las crisis hemolíticas es frecuente y agravan el pronóstico. La letalidad es alta.	Sintomático Internación en Sala o UTI. Administración E.V. de antiveneno loxosceles* Laboratorio de ingreso y de seguimiento.



FICHA CLÍNICA PARA CASOS DE ACCIDENTES POR ARANEISMO

CENTRO MÉDICO QUE ASISTE EL CASO			FECHA	
APELLIDO Y NOMBRE	EDAD	SEXO	DOCUMENTO	
	M A	M F		
DOMICILIO			TELÉFONO	
CIRCUNSTANCIA DEL INCIDENTE Fecha: / / 20 Hora: : : Localidad / Departamento: _____ ¿Cómo fue el incidente? - ¿Qué estaba haciendo?			Localización anatómica de la picadura: Llevó al animal a la consulta:	
			S	N

SIGNOS / SÍNTOMAS

Respiratorio:
 Cardiovascular, Pulso: T.A.: / mmHg.
 Neurológico, Pupilas:
 Estado de conciencia:
 Otros:

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS (*)

Latrodectus	Loxosceles	Tityus trivittatus
☐ CPK	☐ Coagulograma	☐ GOT - CPK
☐ Amilase	☐ Hemoglobinuria	☐ Amilase
☐ Est. Ácido-base	☐ Hepatograma	☐ Glucemia
☐ E.C.G.		☐ E.C.G.

Hemograma, Uremia, Creatinemia, Ionograma; Sedimento de Orina

LATRODECTISMO (*)

- ☐ Dolor local (punzante / urente)
- ☐ Edema local
- ☐ Ansiedad / Agitación
- ☐ Temblores / Contracturas
- ☐ Dolor Abdominal
- ☐ Sudoración generalizada
- ☐ Mialgias
- ☐ Dificultad para caminar
- ☐ Cefalea
- ☐ Taquí / Bradicardia
- ☐ Hipertensión arterial
- ☐ Taquipnea / Disnea
- ☐ Náuseas / Vómitos
- ☐ Retención urinaria

LOXOSCELISMO (*)

- ☐ Dolor local
- ☐ Edema manifiesto y doloroso
- ☐ Necrosis local
- ☐ Placa livida / marmorea
- ☐ Vesículas
- ☐ Escalofríos
- ☐ Vómitos
- ☐ Cefalea
- ☐ Astenia
- ☐ Fiebre
- ☐ Hemoglobinuria
- ☐ Anemia hemolítica
- ☐ Ictericia
- ☐ Insuficiencia renal aguda

ESCORPIONISMO (*) (Tityus trivittatus)

- ☐ Dolor local (urente)
- ☐ Parestesia local
- ☐ Sudoración generalizada
- ☐ Náuseas / Vómitos
- ☐ Taquicardia
- ☐ Hipertensión
- ☐ Ansiedad / Excitación
- ☐ Confusión mental
- ☐ Sialorrea / Rinorrea / Epifora
- ☐ Arritmias
- ☐ Espasmos musculares
- ☐ Palidez / Hipotermia
- ☐ Compromiso hemodinámico
- ☐ Compromiso respiratorio (EAP)

TRATAMIENTO (*)

GENERAL

- ☐ Asepsia local
- ☐ Cobertura Antitética
- ☐ Corticoides
- ☐ Difenhidramina
- ☐ Analgésico
- ☐ Antiemético
- ☐ Hidratación Parenteral
- ☐ Gluconato de Calcio 10%

ESPECÍFICO (Antiveneno)

Hora aplicación: : :
☐ Latrodectus
☐ Loxoscelico
☐ Escorpionico (anti Tityus trivittatus)
 Dosis: ampollas/frascos.
 Reacción al suero:
☐ Favorable
☐ Intolerancia

EL PACIENTE PERMANECE EN

- ☐ Observación
- ☐ Internado en Sala
- ☐ Internado en UTI
- ☐ Derivado Hospital

CLASIFICACIÓN DEL CUADRO CLÍNICO (*)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ☐ LEVE | ☐ GRAVE |
| ☐ MODERADO | ☐ FATAL |

EVOLUCIÓN / OBSERVACIONES:

Firma y Sello del Médico Tratante

La ficha debe remitirse a la División Zoonosis - Fax 261-4235527 - Cnel. Rodríguez 1209 - Mendoza.
 Notificar por Planilla C2 al Departamento de Epidemiología.

Realice siempre la consulta al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico - TEL 261-4282020

(*) Guías de diagnóstico y tratamiento de los envenenamientos por animales peçonhentos. Departamento de Toxicología - Ministerio de Salud - Gobierno de Mendoza.